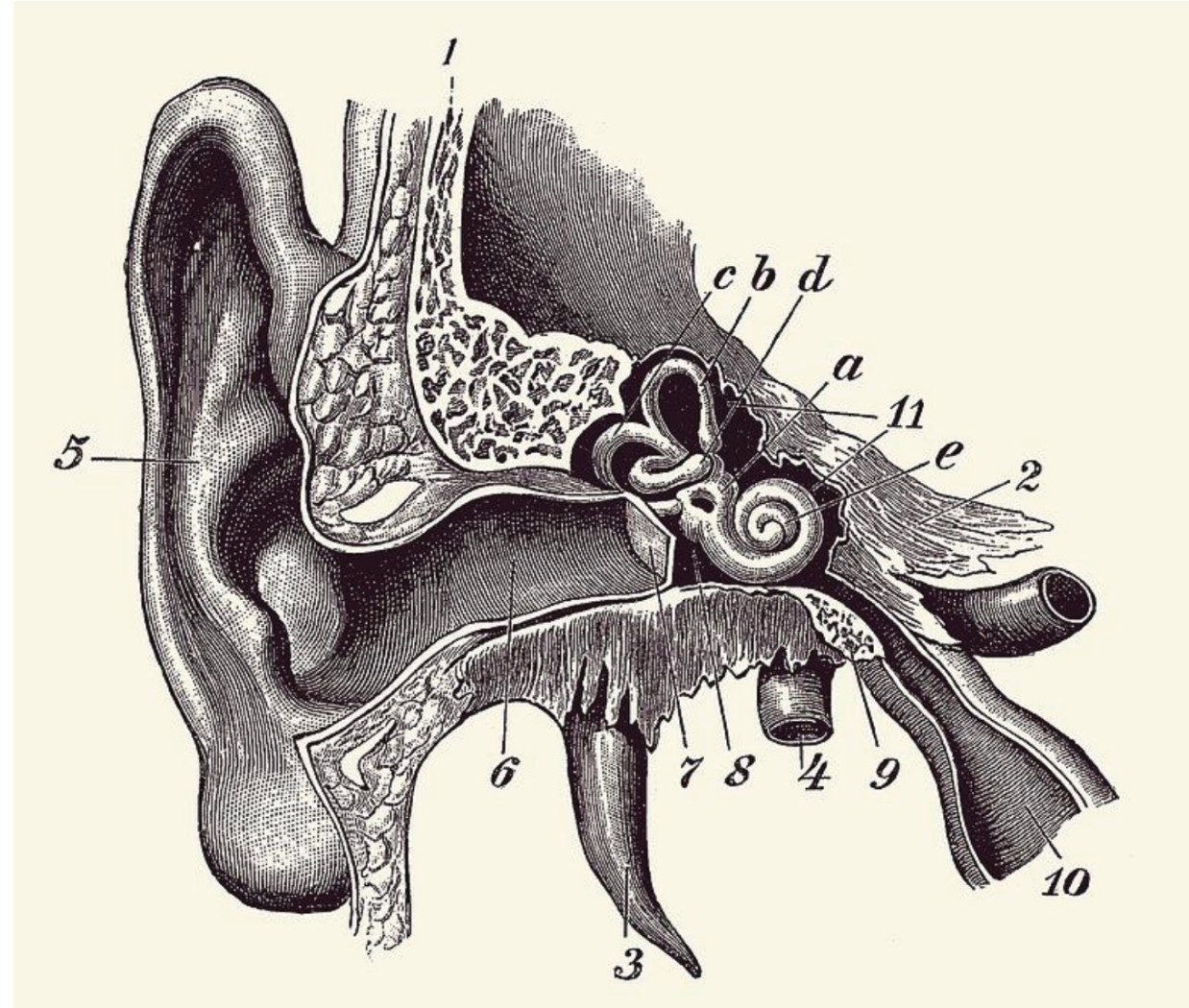
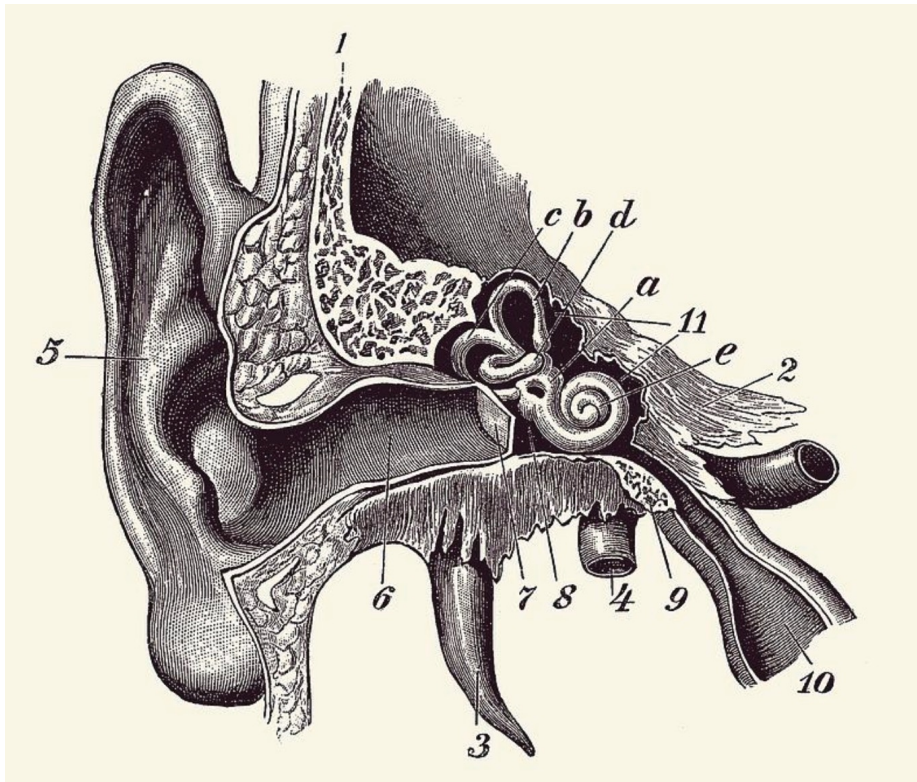


ORL : Pathologies fréquentes



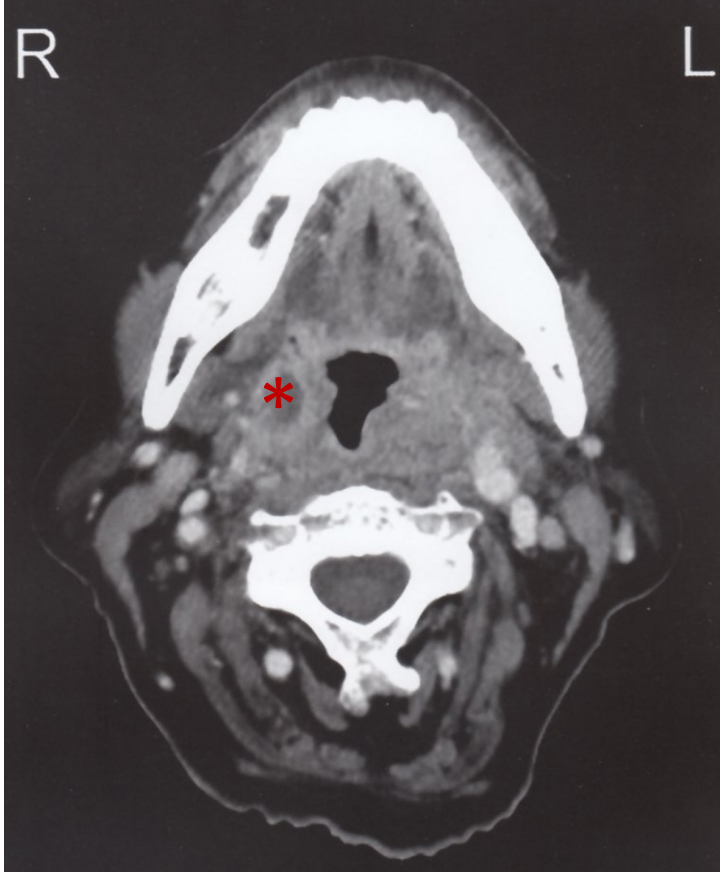


Angine et pharyngite :

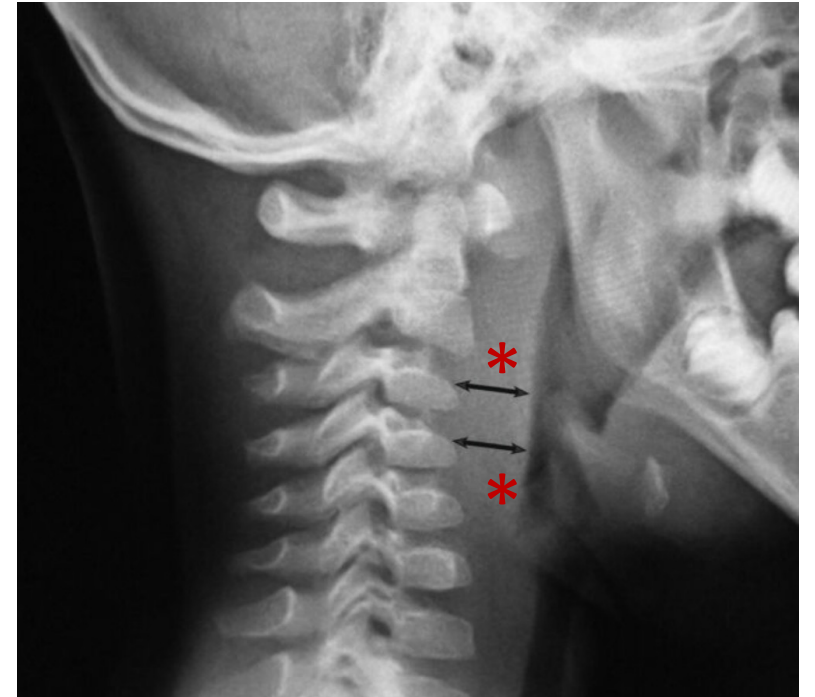
- Définition :** Inflammation le plus souvent **aiguë** (< 3 mois) du pharynx et des amygdales. Étiologie si aiguë :
 - **70% virale** : Adénovirus, EBV, CMV, HSV, coronavirus, rhinovirus, influenza et parainfluenza...
 - **30% bactérienne** : **SGA** > *N. gonorrhoeae*, *C. diphtheriae*, *M. pneumoniae*, *F. necrophorum* et *T. vincentii**
 Les angines **chroniques** (durée > 3 mois) ou **récurrentes** (≥3 épisodes par an) sont plus rares.
 En général, elles sont causées par une **flore polymicrobienne mixtes** (anaérobies et aérobies)
- Cliniques:**
 - Virale** : Douleurs et érythèmes + rhinite, conjonctivite, diarrhée, aphtes et absence de fièvre
 - Bactérienne** : Douleurs(+) avec dysphagie, exsudat amygdalien, pétéchie au palais, adénopathie, fièvre
 Si infection par SGA sous la forme de la **scarlatine** : En plus exanthème scarlatiniforme et langue framboisée
- Red flag (complication d'une infection bactérienne):**
 Indique la formation d'abcès péri-tonsillaire et rétro-pharyngé, d'une mastoïdite ou d'un sepsis.
Trismus (incapacité ouvrir bouche, spasme muscle masticateur) indiquant une abcès péri-tonsillaire
Déviations de l'uvule palatine, atteinte unilatérale, torticollis : indicatrice d'un abcès
Immunosuppression ou **qSOFA** indicateur d'un sepsis : risque d'infection disséminée
 En présence de red flag : **CT en urgence et avis ORL**
- Diagnostic:**
 Si origine virale suspectée, aucun test n'est nécessaire. Possible **sérologie EBV** pour documenter une séroconversion. Conserver un degré de suspicion bas pour le HIV (si doute : **test Combi 4^e génération**)
 Si infection SGA suspecté : **Score de Centor** puis frottis et **test rapide** (ou culture).
 Si une autre infection bactérienne est suspecté, faire le test adapté (cave: **Angine de Plaut-Vincent* → gram)
- Traitement :**
 En général uniquement symptomatique, même en cas d'infection SGA.
 Si traitement antibiotique nécessaire, donner la **pénicilline V po 10 jours** (ou pénicilline G parentérale).
 Si infection par anaérobe suspecté (angine de Plaut-Vincent ou récidivante) : **Pénicilline + Métronidazole**
 Si red-flag avec abcès/sepsis : Antibiotique IV (**Co-amoxiciline**) ± drainage chirurgical

**Rx normal (N) versus
abcès rétro-pharyngé(*)**

***Abcès para-parynhé**



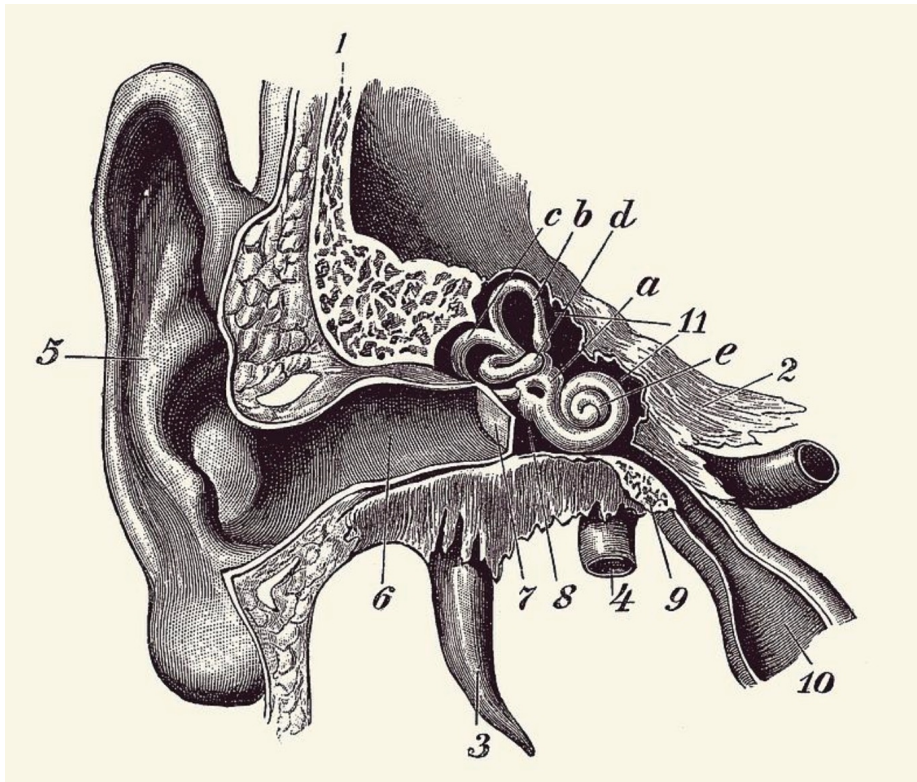
***Abcès péri-tonsillaire**



Scarlatine :

- **exanthème scarlatiniforme**
- **Flush avec pâleur péri-orale**
 - **langue framboisée**





Laryngite :

- **Définition :** Inflammation aiguë ou chronique du larynx et des cordes vocales.
Les **laryngite aiguë** sont souvent d'origine infectieuse (viral >> bactérienne), parfois environnementale (irritant, polluant, chants prolongés...) ou la manifestation d'une maladie auto-immune (sarcoïdose, RA, GPA...).
- Les **laryngites chroniques** sont souvent causé par une RGO, le tabac ou des IVRS récurrentes.
- **Cliniques:** Extinction de la voix, toux sèche, EF et adénopathie (si infectieux), stridor inspiratoire (si sévère)...
Autres symptômes de la maladie sous-jacente.
- **Diagnostic:** Si nécessaire laryngoscopie direct ou indirect.
- **Traitement :** Le plus souvent celui de la cause sous-jacente ou tt symptomatique le temps de l'infection virale.

Faux-croup (laryngo-trachéite virale) :

- **Définition :** Forme particulière de laryngite touchant les enfants entre **6 mois et 3 ans**.
D'origine virale (contrairement à la diphtérie = vrai-croup) : **para-influenza** > RSV, Adenovirus, coronavirus...
- **Cliniques:** Rhinite, stridor et dyspnée, **toux « aboyante »**
- **Diagnostic:** Uniquement clinique le plus souvent.
Rx de thorax avec **rétrécissement sous-glottique** (cave non spécifique)
DD: Vrai-croup, épiglottite
- **Traitement :** **Dexaméthasone PO** + **antipyrétique** et **fluide IV** pour tous les patients,
Donner de l'**O2** et des **nébulisation d'adrénaline** si nécessaire

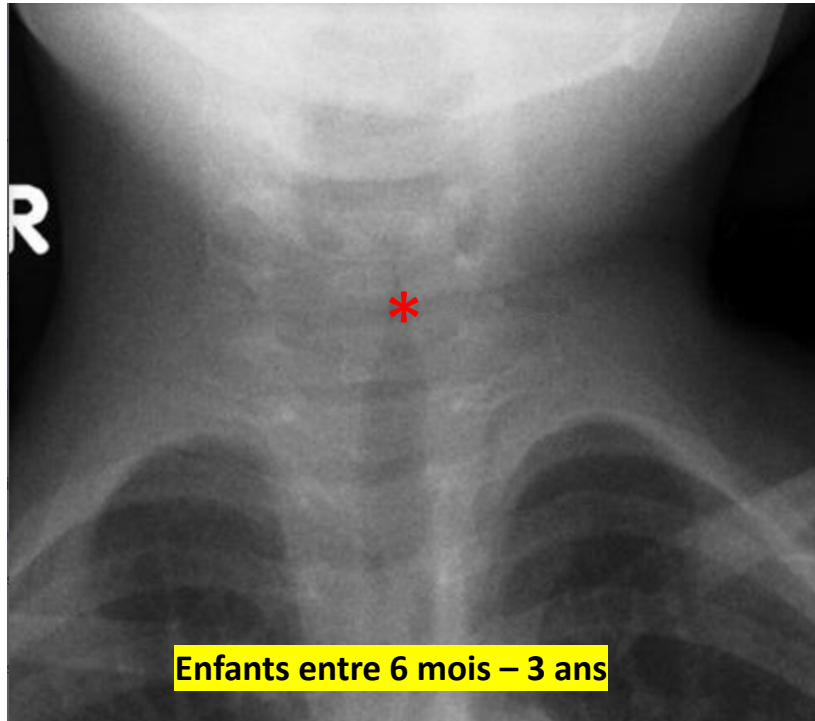
Vrai-croup (laryngo-trachéite bactérienne) :

- **Définition :** Forme particulière de laryngite causé par la toxine de **C. diphtheriae**.
- **Cliniques:** Stridor inspiratoire, dyspnée. Parfois en présence d'une angine avec **dépôt grisâtre** et de pharyngite.
Possible manifestation extra-respiratoire dû à l'effet systémique de la toxine avec un **cardite**, des **arythmies**, des polyneuropathies, des arthrites...
- **Diagnostic:** **Culture** et **gram** (ou coloration de Albert) des frottis pharyngés et tonsillaire, **PCR**.
- **Traitement :** Initier le traitement causal avant confirmation du diagnostic !
Penicilline G parentérale ou **Erythromycine IV/po** pour 14 jours + **antitoxine IV**.
Traitement symptomatique si nécessaire (O2, VNI, intubation...).
- **Prévention :** Vaccination contre la toxine diphtérique (**Vaccin DTP**) → y-penser chez les **enfants non vaccinés** !

Épiglottite :

- **Définition :** Inflammation bactérienne de l'épiglotte. Causé par l'Hib > *S. pyogenes*, *S. pneumoniae*, *S. aureus*
- **Cliniques:** Touche en particulier les enfants entre **6 et 12 ans**. **Stridore inspiratoire**, dyspnée soulagé par position en **tripode**, odyndysphagie, **voix de « patate chaude »**, **absence de toux** (non viral !), fièvre élevée
- **Diagnostic:** Surtout clinique (**tripode** + **patate chaude** + aspect toxique). Si besoin, visualisation de l'épiglotte par laryngoscopie (in)directe, Rx latérale du cou avec visualisation des tissus mous voir CT-injecté (adulte).
Frottis du pharynx avec culture et hémoculture.
- **Traitement :** Toujours commencer **surveillance aux SI**, FiO2 100% voir intubation si nécessaire
Antibiothérapie IV empirique jusqu'à identification du germe : **Amoxicilline-acide clavulanique**

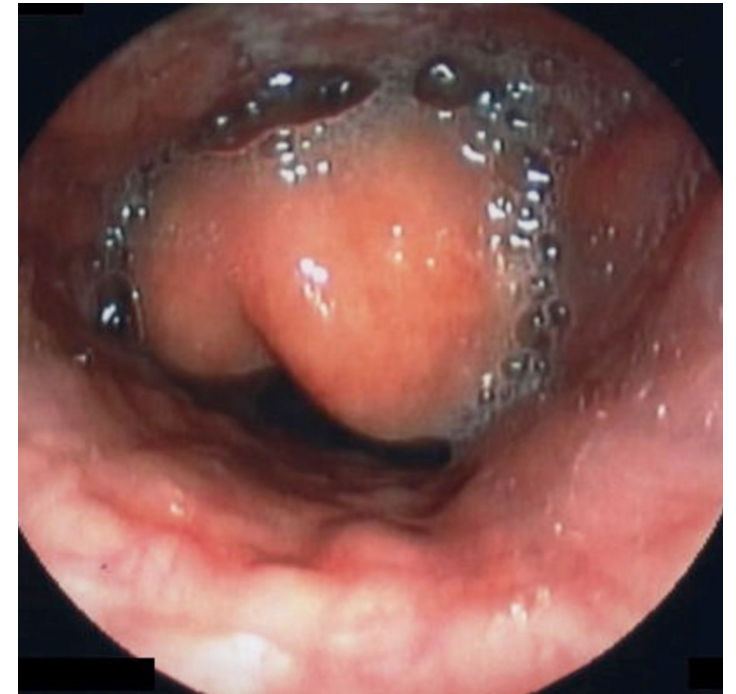
Laryngo-trachéite (faux et vrai croup) :
Rétrécissement



Epiglottite sur CT-injecté



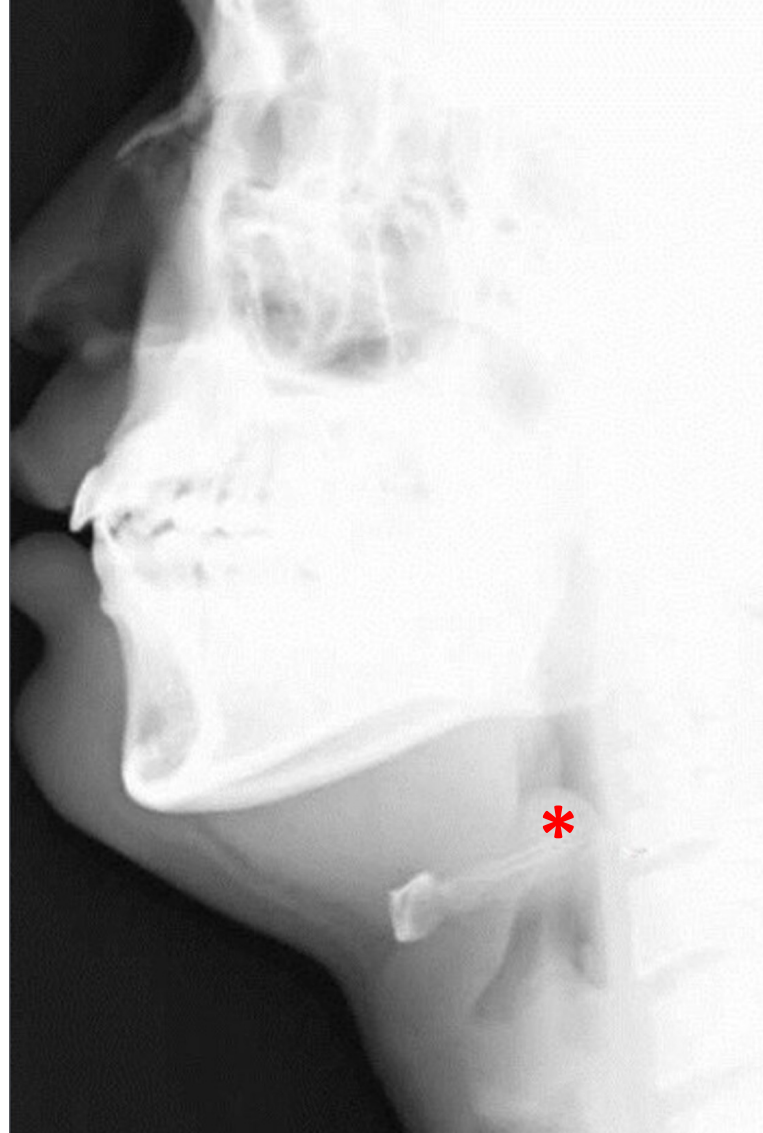
Epiglottite à l'endoscopie



Épiglotte normale

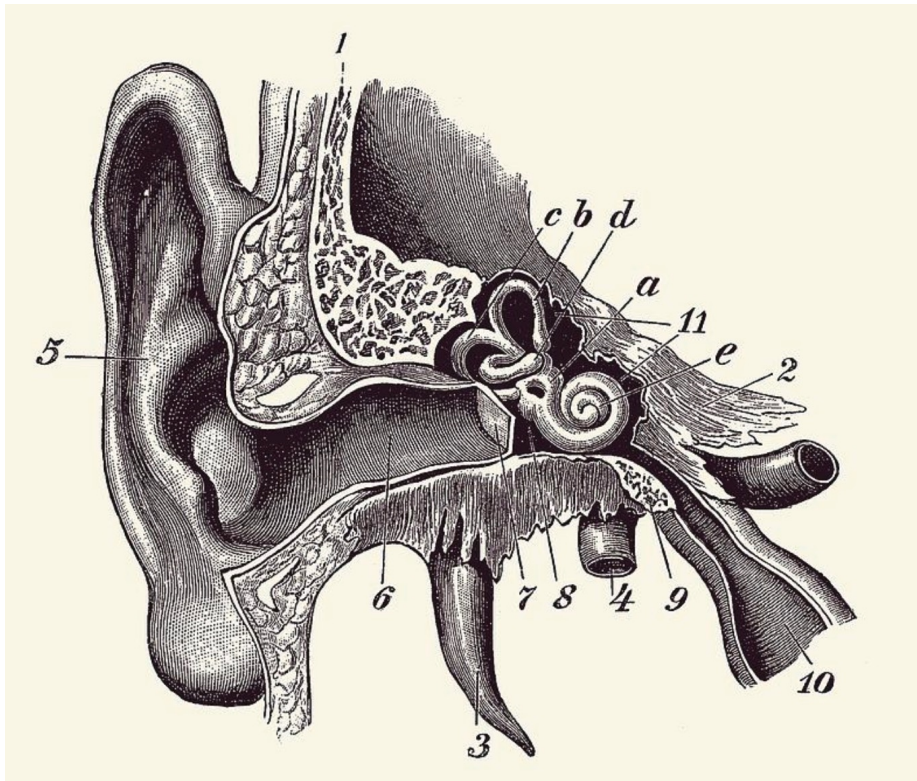


Epiglottite sur Rx



Epiglottite sur Rx





Paralysie faciale :

- Définition :** Atteinte centrale ou périphérique du NC.VII
 La cause la plus fréquente est une paralysie faciale périphérique idiopathique (« **paralysie de Bell** »).
 Les causes secondaires sont nombreuses et peuvent être infectieuses, ischémique/hémorragique, traumatique...
Infectieuses : Syndrome de Ramsay-Hunt (**VZV**, atteinte des NC.VII et/ou VIII), **Lyme**, **HSV**, **HIV**...
Traumatique : fracture de l'os temporal),
Tumorale : Sur le trajet du nerf (**glande parotide**) ou sur un nerf adjacent (**schwannome vestibulaire**),
Sarcoidose : syndrome de Heerfordt (triade parotidite, paralysie faciale, uvéite antérieure),
Syndrome de Guillain-Barré, **Amyloïdose**, Microangiopathie **diabétique**, **Gestation**, **Otite moyenne**...
- Cliniques :** Atteinte isolée du quadrant inférieur controlatérale en cas d'origine centrale,
 Atteinte combinée des quadrant inférieur et supérieur ipsilatéraux lors d'origine périphérique.
 En cas d'atteinte périphérique on peut également retrouver : **Xérose** buccale et sécheresse oculaire, **kératite** et possible ulcération de la cornée, **dysgueusie** de la partie antérieure langue, **hyper-acousie**.
- Diagnostic :** Même si la paralysie de Bell est la cause la plus fréquente, il reste un diagnostic d'exclusion.
 Toujours effectuer une anamnèse et un status neurologique complet. Chercher des signes de paralysie faciale secondaire (érythème migrans, zona auriculaire ou cervicale, vésicules sur l'oreille ou dans le CAE, otite moyenne, masse parotidite, rash...). Si nécessaire, exclure un AVC, une tumeur ou un traumatisme par une imagerie en coup adaptée. En présence de vésicules et de suspicion d'un syndrome de Ramsay-Hunt, effectuer un frottis et une PCR à la recherche du VZV.
 En l'absence de causes évidentes (ci-dessus), il faut *a minima* effectuer le bilan suivant avant de conclure à une paralysie idiopathique : **sérologie HIV**, dépistage **syphilis** (**TPHA** puis si positif VDRL), **sérologie B. burgdorferi**,
Traitement : Soins oculaires et prévention de la dessiccation dans tous les cas d'atteinte périphérique.
 Si paralysie de Bell : **Prednisone** dans les 72h du début des symptômes ± **valacyclovir**
 Récupération complète dans les 3 semaines dans ≈ 85% des cas
 Si Lyme : **Doxycycline** (alternative : **amoxicilline**, **Cefuroxime**), Ceftriaxone (si méningite, encéphalopathie...)
 Si réactivation VZV : **Acyclovir**

Érythème migrant

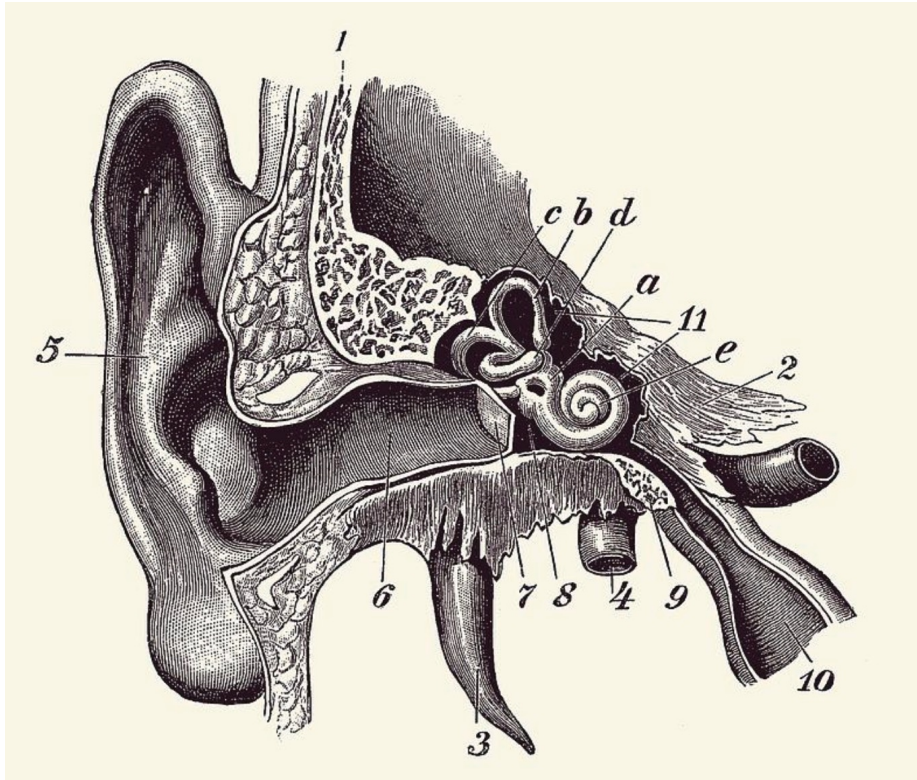


Réactivation VZV



Réactivation VZV



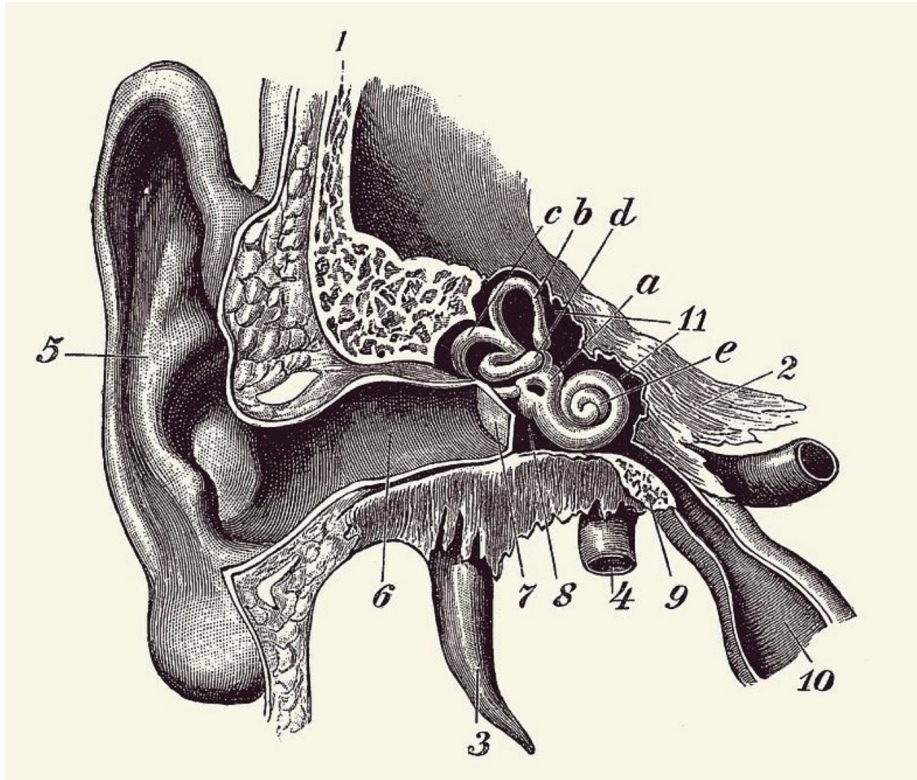


Rhinite non allergique :

- **Définition :** Vasodilatation des plexus veineux de la cavité nasale provoquant un gonflement de la muqueuse, d'origine non allergique (≠ de la rhinite allergique : vasodilatation des vaisseaux sur libération d'histamine et d'autres médiateurs vasoactif dans le cadre d'une hypersensibilité de type 1). Peut-être aiguë ou chronique.
 - **Rhinite infectieuse :** dans le cadre d'une infection virale des voies aériennes supérieures. En général aiguë.
 - **Rhinite non allergique avec éosinophilie :** 1^{ère} cause de rhinite inflammatoire non allergique.
Clinique proche d'une rhinite allergique (polyposse nasale, éternuement, prurit) sans mise en évidence d'une hypersensibilité au moyen de test cutané ou de laboratoire. La présence d'une éosinophilie dans les sécrétions nasales permet de la différencier d'autres causes de rhinite non allergique.
Traitement : **Stéroïdes** topiques ou systémiques, **antihistaminiques**.
 - **Rhinite induite par les médicaments :** Aspirine, médicaments anti-hypertenseurs, médicaments contre troubles érectiles, contraceptifs oraux, neuroleptiques, anti-dépresseurs...
 - **Rhinitis medicamentosa :** induite par un effet rebond après utilisation d'un spray nasal décongestionnant.
 - **Rhinite atrophique :** **Idiopathique** ou secondaire à une maladie **granulomateuse** (auto-immune type vasculite à ANCA ou infectieuse comme la syphilis, la lèpre et *Klebsiella rhinoscleromatis*) ou une **radiothérapie**.
 - **Rhinite vasomotrice :** Congestion nasale **d'origine indéterminée**. Peut-être favorisée par certains médicaments ou modification hormonale (voir plus bas), les changements de température, la pollution, le stress...
Traitement : éviction des triggers si identifiés, spray nasal (solution saline, antihistaminique, stéroïdes, antimuscariniques...). **Largement empirique**
- Rhinite hormonale :** Hypothyroïdie, contraception orale, grossesse, ménopause, puberté...

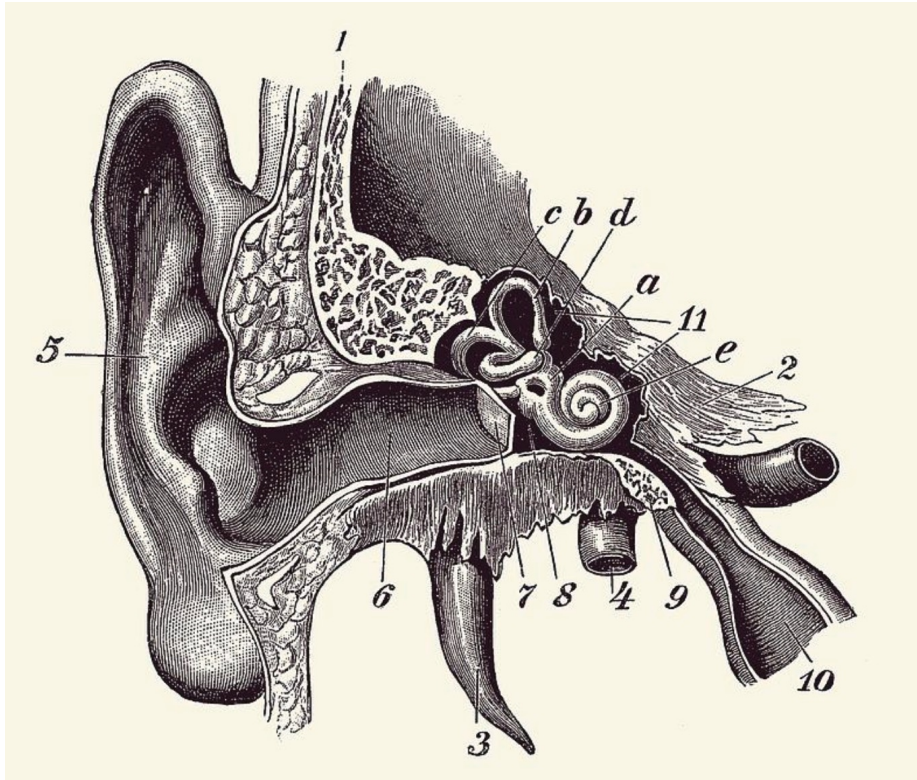
Rhinite allergique :

- **Définition :** Vasodilatation des vaisseaux sur libération d'histamine et d'autres médiateurs vasoactif dans le cadre d'une hypersensibilité de type 1)
- **Cliniques :** Lors du contact avec l'allergène, congestion nasale avec éternuement, écoulement, prurit. Souvent accompagné de conjonctivite allergique et d'un terrain atopique (eczéma, asthme...).
- **Diagnostic :** Test de provocation cutané et test de laboratoire mettant en évidence une sensibilisation et une réaction allergique à un ou plusieurs allergènes.
- **Traitement :** Éviction de l'allergène, désensibilisation, traitement symptomatique par antihistaminique et stéroïdes topiques ou systémiques.



Rhinosinusite aiguë :

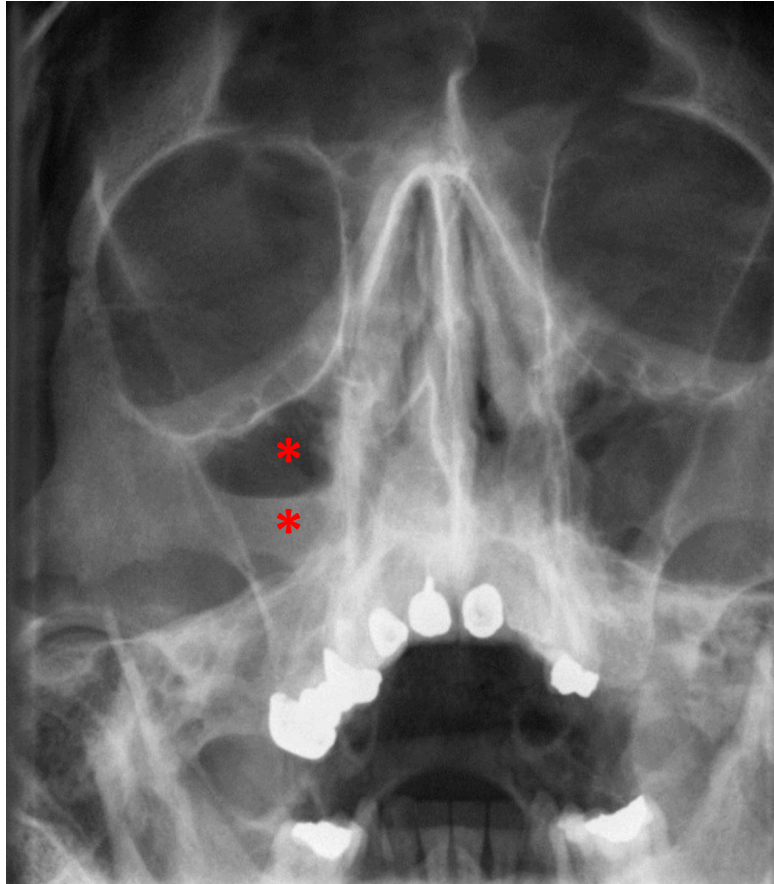
- Définition :** Inflammation de cavité nasale et des sinus adjacents durant < 4 semaine.
 L'origine de la sinusite aiguë est le plus souvent virale, plus rarement bactérienne ou fongique.
 On parle de **sinusite aiguë récidivante** lors de 4 épisodes ou plus de sinusite par année entrecoupée de phase d'au moins 8 semaines sans symptômes.
Virus : Coronavirus, parainfluenza, influenza, rhinovirus, adénovirus
Bactéries : *S. pneumoniae*, *H. influenzae* (75% cas) >> *M. catharralis*, *S. aureus*, *E. coli*, *K. pneumoniae*
Champignon : *Aspergillus spp.* et mucormycose à *Rhizopus oryzae*
- FR : IVRS virale préexistante** (facteur risque le plus fréquent pour des surinfections bactériennes),
Anomalie anatomique ou fonctionnelles des sinus (déviation septum nasal, dyskinésie),
Atopie : Terrain d'asthme ou d'allergie préexistante avec rhinite allergique, intolérance aux AINS...
Désordre immunitaire : vasculite à ANCA, immunosuppression
Mauvaise hygiène dentaire avec extension d'une infection vers les sinus maxillaires.
- Cliniques :** Éternuement, congestion nasale avec écoulement (**rhinite**) + céphalées et douleurs à la percussion des sinus touchés (**sinusite**) ± fièvre, malaise, baisse de l'état général (infection).
 - Atteinte des **sinus maxillaires** : douleurs référées dans les dents,
 - Atteinte des **sinus frontaux** : douleurs dans le front / céphalées frontales,
 - Atteinte des **sinus éthmoïdes** : céphalées rétro-oculaire.
 - Sinusites bactériennes** : Péjoration brutale après une première phase d'amélioration (surinfection), sécrétions nasales purulentes, fièvre importante (> 39°C)
 - Sinusite fongique** : Patient immunocompromis (y-compris diabète) ou après un trauma/chirurgie. Épistaxis, croûtes noires, érosion osseuse à l'imagerie
 - Red flag :**
Altération du status mental, fièvre >39°C ou/et durant > 72h, céphalées très importantes,
Déficit neurologique focal, **anomalie oculaire** (oculomotricité, douleurs, flou visuel...),
 Absence d'amélioration après 72h d'une antibiothérapie bien conduite,
Rhinosinusite aiguë récidivante,
Immunosuppression (y-compris diabète)
- Complication :** Cellulite orbitaire, abcès orbitaire, thrombose du sinus caverneux, Méningite, abcès cérébraux ou sous-duraux, pneumonie voir sepsis.
- Diagnostic :** Diagnostic clinique, recourir à l'imagerie ou l'endoscopie uniquement si **red-flag**
- Traitement :** **NaCl**, **CS topique**, traitement de la douleur avec **AINS/paracétamol**, spray **décongestionnant**.
 Utilisation d'antibiotique lors d'infection bactérienne suspecté (**co-amoxiciline** pour 5-10 jours) : Red-flag ou péjoration aiguë après une amélioration initiale, sécrétions nasales purulentes.
 Si suspicion de sinusite fongique, demandez immédiatement un avis infectiologique et ORL ! Mortalité >50%



Sinusite chronique :

- **Définition :** Inflammation chronique (durée >12 semaines) de la cavité nasale et des sinus, entrecoupés d'exacerbations causées par des infections surajoutées.
On trouve plus fréquemment des infections à **M. catharralis**, **S. aureus** et **BGN** dans la sinusite chronique.
- **Cliniques:** Persistance insidieuse d'écoulement nasal, céphalées, congestion nasale et hyposmie.
 - Sous-type de « sinusite chronique **avec polypose nasales** » : Associé à de l'asthme, l'intolérance à l'aspirine/AINS (cave triade de Widal), la rhinite allergique et la mucoviscidose.
 - Sous-type de « sinusite chronique **sans polypose nasales** » : Associée à des anomalies anatomiques (déviation du septum, masses/tumeurs ou une mauvaise hygiène dentaire).
- **Diagnostic :** Diagnostic clinique mais toujours effectuer une fois une imagerie en coupe et/ou endoscopie. Si nécessaire, effectuer des cultures lors d'épisodes de surinfections.
Le diagnostic des polyposes nasale repose sur la cytologie des écoulements nasaux à la recherche d'une éosinophilie, et l'endoscopie ou le CT pour la visualisation des polypes et l'exclusion des autres causes d'obstruction nasale. L'endoscopie permet également de biopsier les polypes pour exclure une tumeur.
- **Traitement :**
Irrigation avec **NaCl**, **CS topique**, traitement de la douleur avec **AINS/paracétamol**, spray **décongestionnant**. Utilisation **d'antibiotique** lors d'infection bactérienne avec exacerbation (**co-amoxicilline** pour 5-10 jours, si nécessaire FQ ou C3G/C4G en dernière intention). Si nécessaire **résection endoscopique** des polypes. Si possible, traitement de la maladie sous-jacente (déviation septum, tumeurs...).

Rx avec niveau hydro-aérique
cave : Aujourd'hui, préférer faire un CT



Sinusite chronique avec polypose

